

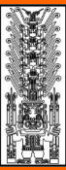
Universidad Nacional
Federico Villarreal

Facultad de Medicina

Semana 01

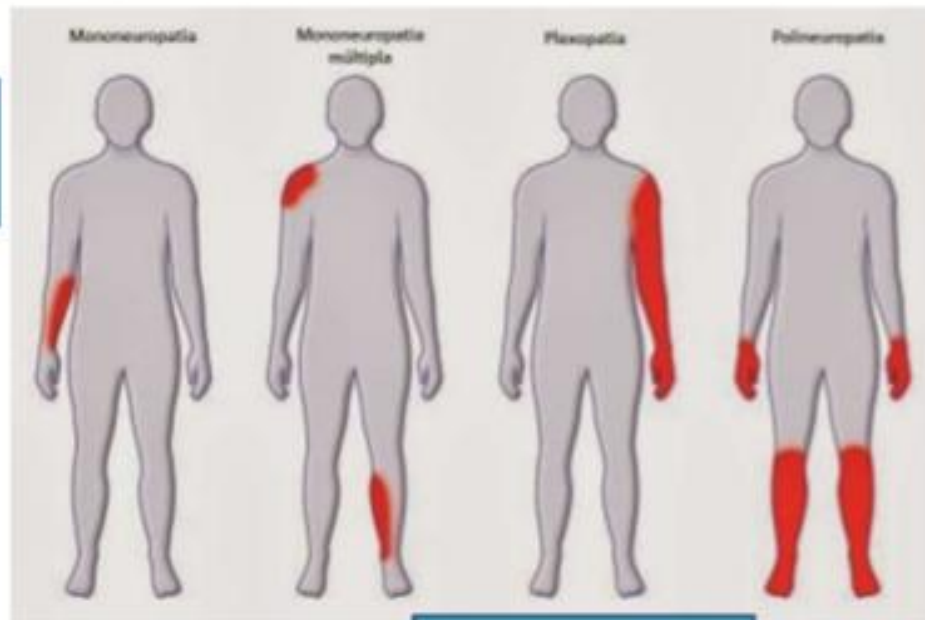
Asignatura: Neurología Clínica
Dra. Lucía Rodríguez Miranda

Semestre Académico 2025-1



POLINEUROPATIAS

Por trauma o
atrapamiento



Compromiso de varios
nervios separados en
tiempo y no contiguos

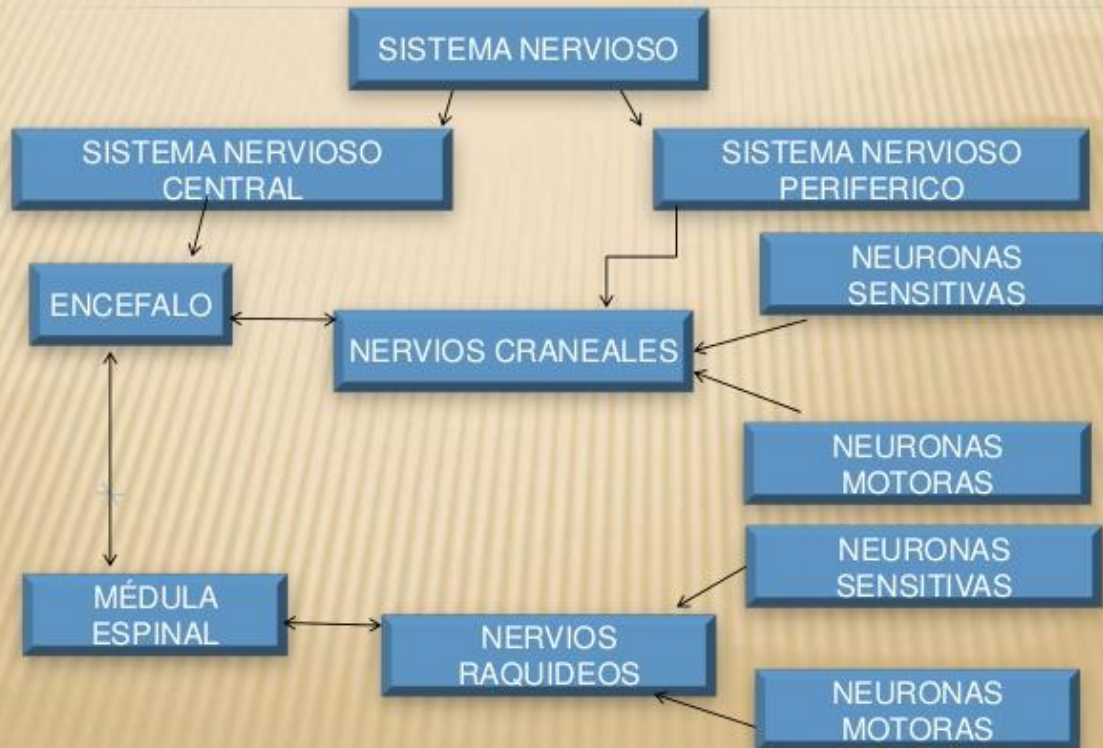
Compromiso de varios
nervios en una sola
extremidad.(braquial,
lumbosacra)

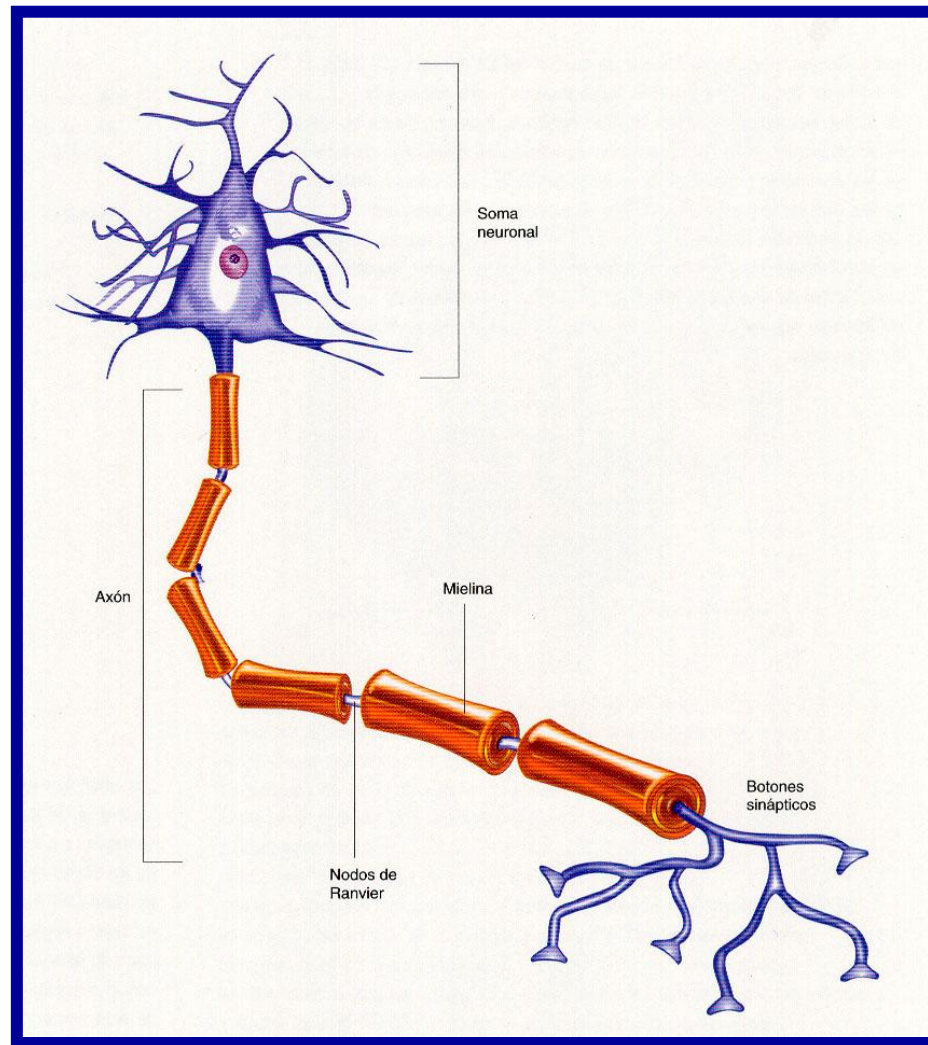
Que afecta a varios
nervios,
bilaterales,
distales y simétrica

Radiculopatías
afección simple o
múltiple de las
raíces nerviosas



CLASIFICACIÓN ANATÓMICA DEL SISTEMA NERVIOSO







SINDROME DE GUILLAN BARRE

- ES LA CAUSA MAS FRECUENTES DE LA PARALISIS FLACCIDA AGUDA AFECTA A TODAS LAS EDADES.
- EN LA MAYORIA DE PACIENTES HAY EL ANTECEDENTE DE INFECCION DEL TRACTO DIGESTIVO O RESPIRATORIO
- LA PATOGENIA IMPLICADA ES UNA RESPUESTA AUTOINMUNE



SINDROME DE GUILLAN BARRE

A. MANIFESTACIONES CLINICAS

1. DEBILIDAD MUSCULAR SIMETRICA, AGUDA, PROGRESIVA, ASCENDENTE ALCANZA UNA MESETA A LAS 4 SEMANAS Y LUEGO SE INICIA LA RECUPERACION A LA 2 – 4 SEMANAS.
2. LA ARREFLEXIA ES CARACTERISTICA
3. ES FRECUENTE LA DISFUNCION AUTONOMICA.



SINDROME DE GUILLAN BARRE

B. VARIEDADES

1. POLIRRADICULOPATIA INFLAMATORIA DESMIELIZANTE AGUDA

- EN LA MAYORIA ANTECEDENTE DE INFECCIÓN PREVIA
- DESMIELINIZACION Y GRADO VARIABLE DE INFILTRACION LINFOCITICA



SINDROME DE GUILLAN BARRE

B. VARIEDADES

2. NEUROPATIA AGUDA SENSITIVOMOTORA AXONAL (AMSAN)

- INICIO FULMINANTE DE PARALISIS GRAVE Y DEFICIT SENSITIVO
- COMPROMISO DE FIBRAS MOTORAS Y SENSITIVAS
- LA RESPUESTA INMUNE ESTA DIRIGIDA CONTRA EL AXON



SINDROME DE GUILLAN BARRE

B. VARIEDADES

3. NEUROPATIA AGUDA MOTORA AXONAL (AMAN)

- AFECTACION CLINICA Y ELECTROFISIOLOGICA PURAMENTE MOTORA
- LAS PRIMERAS DESCRIPCIONES FUERON EN NIÑOS Y COMO EPIDEMIAS DE VERANO
- EL 76 % PRESENTAN ANTICUERPOS CONTRA C. JEJUNI



SINDROME DE GUILLAN BARRE

B. VARIEDADES

4. SINDROME DE MILLER FISHER (SMF)

- OFTALMOPLEJIA, ATAXIA Y ARREFLEXIA
- DESENCADENADO POR INFECCION ENTÉRICA
- ANTICUERPOS ANTIGANGLIÓSIDO EN 90 % DE PACIENTES (C. JEJUNI)



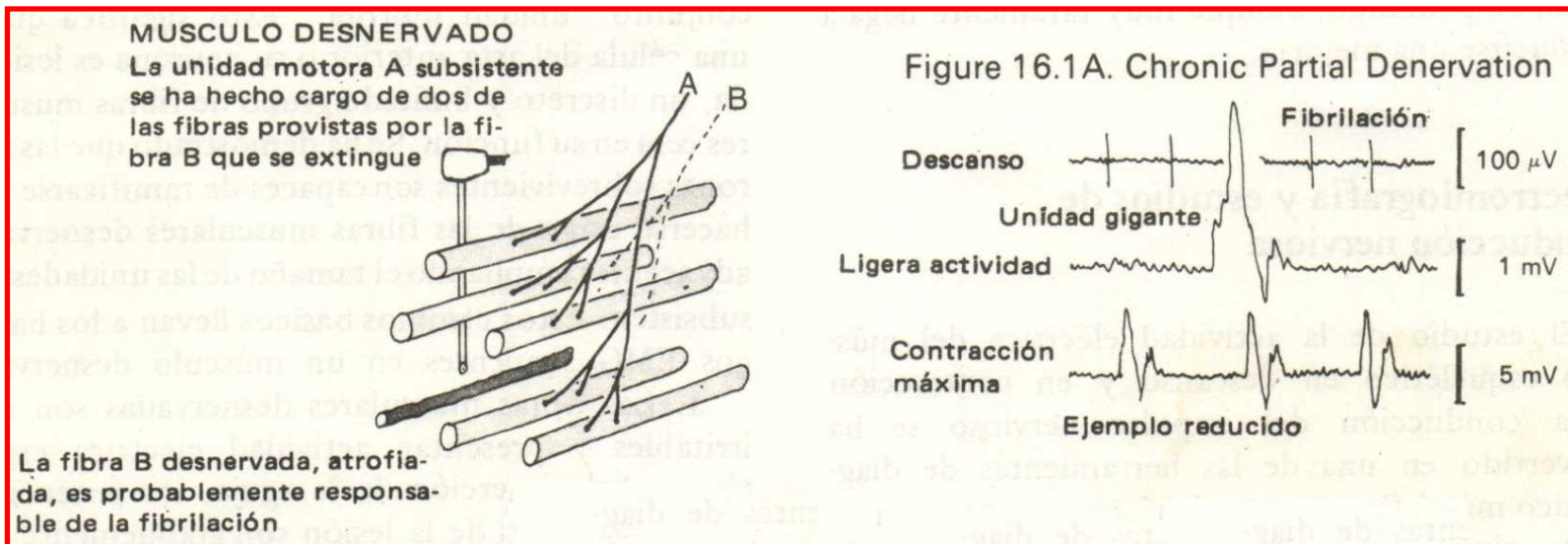
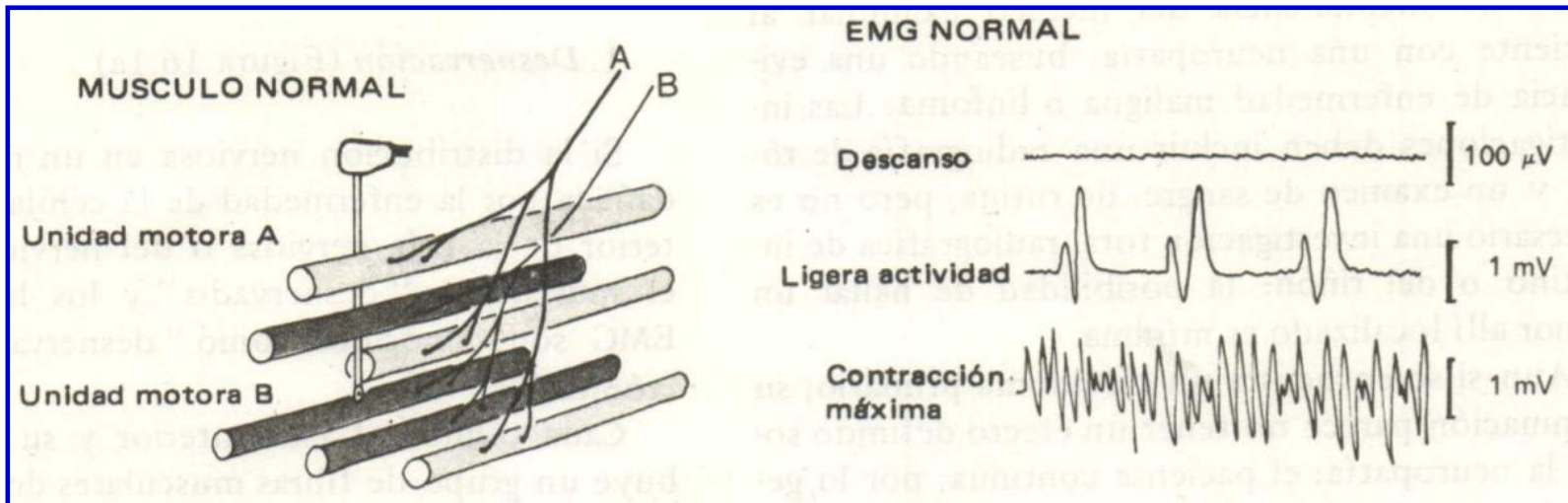
SINDROME DE GUILLAN BARRE

C. EXAMENES

1. LCR DISOCIACION ALBUMINO CITOLOGICA
2. ELECTROFISIOLOGICOS
 - DISMINUCION DE VELOCIDAD DE CONDUCCION
 - ALARGAMIENTO DE LAS LATENCIAS DISTALES
 - BLOQUEOS DE CONDUCCION
 - AUSENCIA DE ONDA F
 - POTENCIALES DE DENERVACION



Músculo Normal vs Músculo Desnervado





SINDROME DE GUILLAN BARRE

D. TRATAMIENTO

1. SOPORTE VITAL

- UCI
- MONITOREO DE CAPACIDAD VITAL : VENTILACION MECANICA
- FISIOTERAPIA RESPIRATORIA
- MONITOREO DE RITMO CARDIACO, PRESION ARTERIAL
- NUTRICION ADECUADA
- MOVILIZACIONES ARTICULARES PASIVAS



SINDROME DE GUILLAN BARRE

D. TRATAMIENTO

2. TRATAMIENTO INMUNOMODULADOR

- PLASMAFERESIS
 - ✓ BENEFICIOSAS EN LAS DOS PRIMERAS SEMANAS
 - ✓ INTERCAMBIOS TOTALES DE PLASMA DE 200 – 250 cm³ / kg. EN 4 – 6 SESIONES DE 2 – 4 Lt. CADA UNA DURANTE 5 – 14 DIAS A DIAS ALTERNOS
- INMUNOGLOBULINAS ENDOVENOSAS
 - ✓ ES EL TRATAMIENTO DE ELECCION EN EL SGB
 - ✓ SE ADMINISTRA UN TOTAL DE 2 g / kg. DURANTE 5 DIAS



NEUROPATÍA CRÓNICA INFLAMATORIA DESMIELINIZANTE

A. POLINEUROPATIA CRÓNICA DESMIELIZANTE IDIOPÁTICAS (CIDP)

POLINEUROPATIA ADQUIRIDA DE PRESUNTA ETIOLOGIA AUTOINMUNE

DEBILIDAD MUSCULAR DE EXTREMIDADES, HIPORREFLEXIA,
ALTERACION DE SENSIBILIDAD Y PARESTESIAS.

INICIO INSIDIOSO EN SEMANAS, MESES O AÑOS CON PATRON
PROGRESIVO O REMITENTE – RECIDIVANTE.



NEUROPATÍA CRÓNICA INFLAMATORIA DESMIELINIZANTE

a) MANIFESTACIONES CLÍNICAS

- DEBILIDAD MUSCULAR TANTO PROXIMAL COMO DISTAL, SIMÉTRICA.
- DÉFICIT SENSITIVO CON ATAXIA.



NEUROPATÍA CRÓNICA INFLAMATORIA DESMIELINIZANTE

b) EXAMENES

- LCR:
 - ✓ DISOCIACIÓN ALBUMINO – CITOLÓGICA
- OTROS:
 - ✓ GAMMAPATIA, MONOCLONAL, VIH, LES, HODGKIN

c) TRATAMIENTO

- CORTICOIDES:
 - ✓ 1 mg / Kg. / DE PREDNISONA POR 4 SEMANAS Y LUEGO DISMINUIR GRADUALMENTE
 - ✓ SI NO HAY RPTA. BENEFICIOSA MANTENER DOSIS ALTAS POR 3 – 6 MESES.
- INMUNOGLOBULINAS E.V.:
 - ✓ DOSIS 0.4 mg. / kg. / DÍA POR 5 DÍAS
- PLASMAFERESIS:
 - ✓ RESERVADA PARA LOS QUE NO RESPONDEN A INMUNOGLOBULINA



NEUROPATIA METABOLICAS ADQUIRIDAS

a) EN INSUFICIENCIA RENAL CRONICA

- INICIA CON SINTOMAS SENSITIVOS DE PREDOMINIO EN EXTREMIDADES INFERIORES CON DEFICIT MOTOR LEVE, ES DISTAL Y SIMETRICA

b) EN HEPATOPATIAS

- LA HEPATITIS VIRAL AGUDA PUEDE ACOMPAÑARSE DE S. GUILLAIN – BARRE.
- LA HEPATITIS VIRAL CRONICA PUEDE DAR NEUROPATIA PERIFERICA POR VASCULOPATIA.
- LA CIRROSIS PUEDE DAR NEUROPATIA SENSITIVA CRONICA ATAXICA.



NEUROPATIA METABOLICAS ADQUIRIDAS

c) POLINEUROPATIA HIPOTIROIDEA

- DE CLARO PREDOMINIO SENSITIVO, ES RARA, PUEDE PRECEDER EN AÑOS A LA APARICION CLINICA DE HIPOTIROIDISMO



NEUROPATIA DIABETICA

LA D.M. ES LA CAUSA MAS FRECUENTE DE NEUROPATIAS EN PAISES DESARROLLADOS

MAS FRECUENTE EN PACIENTES CON MAL CONTROL DE SU DIABETES

a) FORMAS CLINICAS

1. POLINEUROPATIA SIMETRICA DISTAL SENSITIVA O SENSITIVOMOTORA.
 - DISMINUCION DISTAL DE SENSIBILIDAD SUPERFICIAL Y PROFUNDA EN GUANTE Y CALCETIN, DEFICIT MOTOR DISTAL E HIPORREFLEXIA, PREDOMINIO EN EXTREMIDADES INFERIORES.



NEUROPATIA DIABETICA

2) NEUROPATIA AUTONOMICA

- EN 20 – 40 % DE DIABETICOS LAS MANIFESTACIONES MAS FRECUENTES SON: AFECTACION DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR (FRECUENCIA CARDIACA, HIPOTENSION POSTURAL, INFARTO DE MIOCARDIO NO DOLOROSO) Y GENITOURINARIO (ATONIA URINARIA, DISPAREUNIA, IMPOTENCIA)
- ALTERACIONES GASTROINTESTINALES (ATONIA ESOFAGICA, ALTERACION DE MOTILIDAD INTESTINAL Y TRASTORNOS ESFINTARIOS) TERMORREGULACION (SUDORACION Y RPTA. VASOMOTORA)



NEUROPATIA DIABETICA

3. NEUROPATIA MOTORA PROXIMAL

- INICIO BRUSCO O SUBAGUDO, ASIMETRICO.
- AFECTA MUSCULATURA DE CINTURA PELVICA CON DOLOR LUMBAR CONTINUO.
- DEFICIT SENSITIVO LEVE
- ARREFLEXIA ROTULIANA
- MAS FRECUENTE EN VARONES DE EDAD AVANZADA
- MEJORIA EN 6 A 12 MESES



NEUROPATIA DIABETICA

4. MONONEUROPATIA FOCAL

- LOS MAS AFECTADOS POR ATRAPAMIENTO: MEDIANO, CUBITAL Y PERONEO
- LOS NERVIOS CRANEALES + AFECTADOS: III SIN CONMPROMISO DE PUPILA, VI Y IV
- LA MONONEUROPATIA TORACOABDOMINAL O RADICULOPATIA DIABETICA ESTA RELACIONADA CON MICROANGIOPATIA.
- SE CARACTERIZA POR DOLOR AGUDO, URENTE, ASOCIADO A PARESTESIAS Y DISESTESIAS EN DERMATOMA DE RAIZ IMPLICADA

b) EXAMENES

LA VELOCIDAD DE CONDUCCION INDICA POLINEUROPATIA AXONAL .

LA E.M.G. REVELA SIGNOS DE DENERVACION



NEUROPATIA DIABETICA

c) TRATAMIENTO

- CONTROL DE GLICEMIA
- PARA EL DOLOR:
 - ✓ ANALGESICOS MENORES (AAS, PARACETAMOL)
 - ✓ AMITRIPTILINA: 50 – 200 mg /DIA ↑ PROGRESIVO DE DOSIS
 - ✓ CARBAMACEPINA 600 mg – 1200 mg / DIA
 - ✓ GABAPENTINA 900 – 3600 mg / DIA



NEUROPATIA NUTRICIONALES

a) N. POR DEFICIT DE B₁₂

MALABSORCION POR ANEMIA PERNICIOSA, DIETA VEGETARIANA ESTRUCTA.

SINTOMAS SENSITIVOS POR COMPROMISO DE CORDONES POSTERIORES, ASOCIADO A NEUROPATIA PERIFERICA

NIVELES↓ DE VITAMINAS B₁₂, ANEMIA MEGALOBLASTICA

b) N. POR DEFICIT DE ACIDO FOLICO

DIETA POBRE EN ACIDO FOLICO Y TRATAMIENTO CRONICO CON DIFENILHIDANTONIA



NEUROPATIA NUTRICIONALES

c) **N. PRO DEFICIT DE B₆**

CAUSADO POR TRATAMIENTO CON ISONIACIDA

POLINEUROPATIA SENSITIVO – MOTORA LEVE Y NEURITIS OPTICA

TERAPIA PREVENTIVA CON VITAMINA B6 50 – 100 mg / DIA



NEUROPATIAS TOXICAS

POLINEUROPATIA AXONAL DE CURSO SUBAGUDO O CRONICO

N. POR METALES PESADOS

1. ASERNICO

- DOLOR ABDOMINAL, NAUSEAS, VOMITOS Y DIARREAS
- SNC: ALUCINACIONES
- POLINEUROPATIA SENSIVOMOTORA AXONAL SIMETRICA
- DIAGNOSTICO: ARSENICO EN ORINA



NEUROPATIAS TOXICAS

2. PLOMO.

- NEUROPATIA MOTORA DE EXTREMIDADES SUPERIORES QUE OCASIONA PARALISIS RADIAL BILATERAL
- RIBETE GINGIVAL, ANEMIA MICROCITICA
- DIAGNOSTICO: PLOMO INCREMENTADO EN SANGRE



NEUROPATIAS POR FARMACOS

- a) **NITROFURANTOINA → POLINEUROPATIA SENSIVOMOTORA**
- b) **VINCRISTINA**
- c) **AMIODARONA**
- d) **DISULFIRAN**



NEUROPATIAS INFECCIOSAS

A. NEUROPATIAS EN INFECCION POR VIH

FRECUENTE EN ESTADIOS AVANZADOS; MAYORMENTE ASINTOMATICA Y PREDOMINANTE SENSITIVA.

1. P. SIMETRICA DISTAL DE PREDOMINIO SENSITIVO

- ES LA MAS FRECUENTE Y SE PRESENTA EN ESTADIOS MAS AVANZADOS
- DISESTESIAS DISTALES EN EXTREMIDADES INFERIORES ASOCIADOS A DOLOR PLANTAR URENTE
- EN SU EVOLUCION OCASIONA DEFICIT MOTOR MINIMO
- TRATAMIENTO SINTOMATICO



NEUROPATIAS INFECCIOSAS

2. POLIRRADICULONEUROPATIA DESMIELINIZANTE INFLAMATORIA

- ETIOLOGIA AUTOINMUNE
- OCURRE EN FASES TEMPRANAS DE LA ENFERMEDAD
- LA FORMA AGUDA O SINDROME DE GUILLAIN BARRE OCURREN EN LA SEROCONVERSION

3. MONONEURITIS MULTIPLE

- OCURRE EN FASE SINTOMATICA TEMPRANA
- ETIOLOGIA → PROPIO VIH O UNA VASCULITIS
- COMPROMISO SENSITIVO MOTOR MULTIFOCAL



NEUROPATIAS INFECCIOSAS

4. POLIRRADICULOPATIA PROGRESIVA

- ASOCIADA A LA INFECCION POR CMV
- OCURRE EN FASES AVANZADAS
- DOLOR LUMBAR IRRADIADO A UNA EXTREMIDAD.
- POSTERIORMENTE UN SINDROME DE COLA DE CABALLO ASIMETRICO A PREDOMINIO MOTOR.



NEUROPATIAS INFECCIOSAS

B. LEPROA

- MONONEUROPATIA (AFECCION DE TRONCOS NERVIOSOS)
- NEUROPATIA MULTIPLE SENSITIVA (ASIMETRICA Y ASINCRONICA)
- SINTOMAS; ANESTESIA Y PARALISIS
- DIAGNOSTICO: BIOPSIA CUTANEA O DE NERVIO
- TRATAMIENTO: SULFONA
 - ✓ 50 mg. – 100 mg. / DIA → ADULTOS
 - ✓ 1 mg. / Kg. EN NIÑOS



NEUROPATIAS POR ATRAPAMIENTO

A. SINDROME DE TUNEL DEL CARPO

- POR COMPRESION O ISQUEMIA DEL NERVIO MEDIANO
- EN RELACION A FACTORES MECANICOS, MAS FRECUENTE EN MUJERES
- ASOCIADO A OTRAS ENTIDADES
- SINTOMAS: ACROPARESTESIAS DE PREDOMINO NOCTURNO EN TERRITORIO SENSITIVO DEL NERVIO MEDIANO CON SENSACION DE TUMEFACCION, INICIALMENTE UNILATERAL
- DISMINUCION DE LA VELOCIDAD DE CONDUCCION
- TRATAMIENTO: REPOSO E INMOVILIZACION, INFILTRACION CON CORTICOIDES
- QUIRURGICO.



NEUROPATIAS POR ATRAPAMIENTO

B. MONONEUROPATIA DEL CUBITAL

- ATRAPAMIENTO EN EL CODO POR FACTOR POSICIONALES O ARTROSIS
- PARESTESIAS EN EL CUARTO Y QUINTO DEDO Y DEBILIDAD EN MUSCULATURA CORRESPONDIENTE.
- REPOSO Y CORRECCION DE HABITOS EN CASOS LEVES
- QUIRURGICO.



DISTROFIAS MUSCULARES

Dra. Lucia Rodriguez Miranda



DISTROFIAS MUSCULARES

A. MANIFESTACIONES CLINICAS

- HEREDITARIA, CURSO PROGRESIVO, DEBILIDAD Y AMIOTROFIA
- AFECTA CINTURA ESCAPULAR Y PELVICAS, FACIAL
- EN OCASIONES PUEDE INICIAR A NIVEL DISTAL
- PUEDE MANIFESTARSE DESDE EL NACIMIENTO, DURANTE LA INFANCIA CON RETRASO EN LA MARCHA, DURANTE LA ADOLESCENCIA O EN EDAD ADULTA



DISTROFIAS MUSCULARES

B. DIAGNOSTICO CLINICO

- DEBILIDAD MUSCULAR PROGRESIVA PROXIMAL SIN SINTOMAS SENSITIVOS
- ATROFIA MUSCULAR, ROT PRESENTES O LEVEMENTE DISMINUIDOS
- LA DISTRIBUCION , LA EDAD DE INICO, EVOLUCION Y ALTERACIONES ASOCIADAS PERMITEN UNA ORIENTACION ETIOLOGICA
- HISTORIA FAMILIAR ESTABLECE UN PATRON DE HERENCIA



DISTROFIAS MUSCULARES

C. EXAMENES

- AUMENTO DE ENZIMAS MUSCULARES: CK
- CONDUCCION NERVIOSA MOTORA Y SENSITIVAS NORMALES, SI HAY PERDIDA SIGNIFICATIVA DE FIBRAS MUSCULARES HAY REDUCCION DE LA AMPLITUD DEL POTENCIAL MOTOR.
- ELECTROMIOGRAFIA EN REPOSO PRESENCIA DE FIBRILACION Y ONDAS POSITIVAS EN CONTRACCION MAXIMA, PATRON DE INTERFERENCIA PRECOZ
- BIOPSIA MUSCULAR UTIL PARA ETIOLOGIA Y DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
- ESTUDIOS GENETICOS
- OTROS: PRUEBAS FUNCIONALES RESPIRATORIAS, EVALUACION CARDIOLOGICA



DISTROFIAS MUSCULARES

D. TRATAMIENTO NO FARMACOLOGICO

- MULTIDISCIPLINARIO: FISIOTERAPIA, ORTOPEDIA, CIRUGIA

E. TRATAMIENTO FARMACOLOGICO

- CORTICOIDES: PREDNISONA UTIL EN DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE
- DOSIS 0.75 mg / kg / DIA EN MONODOSIS
- INCIO DE TRATAMIENTO EN EL MOMENTO DEL DIAGNOSTICO O SINO CUANDO LAS CAIDAS SON MAS FRECUENTES



MIASTENIA

A. ASPECTOS GENERALES

- ENFERMEDAD AUTOINMUNE QUE CAUSA FATIGA MUSCULAR QUE MEJORA CON REPOSO
- ALTERACION POSTSINAPTICA DE LOS RECEPTORES DE ACETILCOLINA (ACh) EN LA UNION NEUROMUSCULAR POR LA PRESENCIA DE ANTICUERPOS



MIASTENIA

B. SINTOMAS

- FATIGA MUSCULAR DESENCADENADA POR EJERCICIO, MAS INTENSA EN HORAS NOCTURNAS.
 - ✓ AFECTACION DE MUSCULATURA OCULAR EXTRINSECA: DIPLOPIA Y PTOSIS
 - ✓ AFECTACION DE MUSCULATURA BULBAR: ALTERACION DE FONACION , DEGLUCION O MASTICACION.
 - ✓ AFECTACION DE MUSCULATURA FACIAL: ALTERACION DE MIMICA, HABLA
 - ✓ AFECTACION DE MUSCULATURA CERVICAL
- INICIO INSIDIOSO O SUBAGUDO PRECEDIDO POR UN FACTOR DESENCADENANTE (FIEBRE, INFECCION, INTERVENCIONES QUIRURGICAS, EJERCICIOS INTENSOS O USO DE FARMACOS)



MIASTENIA

C. DIAGNOSTICO

- Ac anti – RACH SOLO EN:
 - ✓ 85 % MIASTENIA GENERALIZADA
 - ✓ 50 % MIASTENIA OCULAR
- TEST DE EDROFONIO (TENSILON)
- ELECTROFISIOLOGICOS
 - ✓ ESTIMULACION REPETITIVA
 - ❖ ↓ POTENCIAL MOTOR
 - ❖ FALSOS (+)



MIASTENIA

- ✓ ELECTROMIOGRAFIA DE FIBRA UNICA
- OTROS:
 - ✓ VALORACION DE LA FUNCION RESPIRATORIA
 - ✓ TAC / RM TORACICA



MIASTENIA

C. TRATAMIENTO

- ANTICOLINESTERICOS
 - ✓ INHIBEN LA ACETILCOLINESTERASA Y PROLONGAN LA ACCION DE ACETILCOLINA
 - ✓ PIRIDOSTIGMINA 30 mg – 60 mg / 3 – 4 HORAS
 - ✓ EFECTOS COLATERALES: DIARREA, DOLOR ABDOMINAL
 - ✓ USO DEL ATROPINA 0.4 – 0.8 mg.
 - ✓ NEOSTIGMINA INTRAVENOSA EN DISFAGIA GRAVE (0.5 mg / 1ml)
- TIMECTOMIA
- INMUNOSUPRESORES



Dra. Lucia Rodriguez Miranda

